

Anamnese

→ Anamnese (ana: trazer de novo + mnesis: memória) significa trazer de volta à mente todos os fatos relacionados com a doença e o paciente

ELEMENTOS DA ANAMNESE – ADULTO

- 1- Identificação: perfil sociodemográfico do paciente
- 2- Queixa principal: o motivo que levou o paciente ao médico, colocar de forma breve
- 3- História da doença atual (HDA): registro detalhado e cronológico do motivo que levou o paciente a procurar assistência médica
- 4- Interrogatório Sintomatológico: documenta a existência ou ausência de sintomas comuns relacionados com cada um dos principais sistemas corporais
- 5- Antecedentes pessoais: fisiológicos (desenvolvimento sexual) e patológicos (alergias, cirurgias, medicamentos em uso, vacinas)
- 6- Antecedentes familiares:
- 7- Hábitos e estilo de vida: alimentação, ocupação atual e ocupações anteriores, atividades físicas e hábitos. Cigarro e bebida colocar quantidade e tempo de uso. Parou de fumar há mais de 1 ano – ex-tabagista
- 8- Condições Socioeconômicas e Culturais: avaliam a situação financeira, vínculos afetivos familiares, condições de moradia e grau de escolaridade

ELEMENTOS DA ANAMNESE – CRIANÇA

→ A anamnese na criança segue a mesma ordem que a realizada no adulto, porém possui algumas particularidades, como por exemplo:

- 1- Identificação: nome do informante, relação de parentesco com a criança
- 2- Antecedentes Pessoais: fisiológicos e patológicos

ANTECEDENTES PERINATAIS: Gestação: duração, consultas de pré-natal, intercorrências (sangramento, ITU, rubéola, HAS, DM), ferro, vitaminas, medicamentos, drogas ilícitas, fumo, álcool. Parto: tipo (cesário ou normal), local, sofrimento fetal, condições de nascimento, APGAR (primeiro e quinto minutos), manobras de reanimação, triagem neonatal. Dados antropométricos ao nascer: peso, comprimento, perímetro cefálico. Período Neonatal Imediato: problemas respiratórios, icterícia, medicação, oxigênio, fototerapia

HISTÓRIA ALIMENTAR: alimentação nos primeiros dois anos de vida (aleitamento exclusivo ou artificial), suplementação de ferro e vitaminas

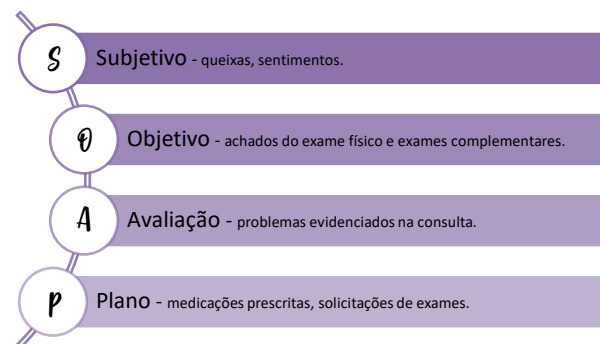
DESENVOLVIMENTO: Idade de aquisição dos seguintes marcos: firmar a cabeça, sorriso espontâneo, segurar objetos, sentar sem apoio, engatinhar, andar sem apoio, controlar esfíncteres, primeiras frases, correr sem dificuldade, subir escadas, linguagem de adulto, beber em copo, usar colher, vestir-se. Rendimento escolar

HISTÓRIA VACINAL: solicitar e verificar o calendário vacinal da criança

HISTÓRIA PATOLÓGICA PREGRESSA: Citar as doenças apresentadas anteriormente, atendimentos em emergência, internações (onde, porque, permanência, etc). Questionar sobre acidentes, cirurgias, alergia a medicamentos e outras alergias, uso contínuo de medicamentos, exames realizados

- 3- Hábitos e estilo de vida: sono (agitado, dorme bem), lazer, atividade física (pratica algum esporte), quantas horas diárias assiste TV.

Registro Baseado em Problemas (ReSOAP)



OBS.: O método SOAP é um exemplo de evolução mais rápido para a APS. O método SOAP é eficaz para o acompanhamento.

Protocolo SPIKES

Tabela 2. O protocolo Spikes

S	Setting up	Preparando-se para o encontro
P	Perception	Percebendo o paciente
I	Invitation	Convidando para o diálogo
K	Knowledge	Transmitindo as informações
E	Emotions	Expressando emoções
S	Strategy and Summary	Resumindo e organizando estratégias

Técnicas de aferição de PA e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)

TÉCNICAS DE AFERIÇÃO DE PA - ADULTO

→ O paciente deve sentar-se confortavelmente em um ambiente silencioso por 5 minutos, antes de iniciar as medições da PA. Explique o procedimento ao indivíduo e oriente a não conversar durante a medição. Possíveis dúvidas devem ser esclarecidas antes ou depois do procedimento.

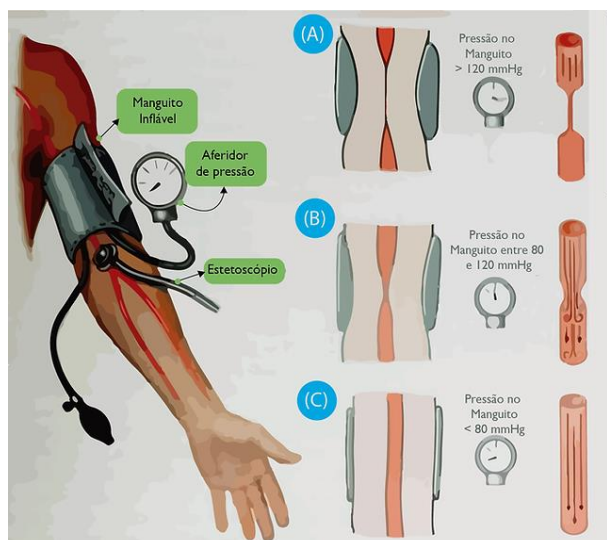
→ Certifique-se de que o paciente NÃO:

- Está com a bexiga cheia;
- Praticou exercícios físicos há, pelo menos, 60 minutos;
- Ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos;
- Fumou nos 30 minutos anteriores

OBS.: Três medidas de PA devem ser realizadas, com intervalo de 1 a 2 minutos; e medidas adicionais somente se as duas primeiras leituras diferirem em > 10 mmHg. Registre em prontuário a média das duas últimas leituras da PA, sem "arredondamentos" e o braço em que a PA foi medida.



OBS.: Caso ocorra uma diferença > 15 mmHg da PAS entre os braços, há o aumento do risco CV o qual, pode estar relacionado com a doença vascular aterosclerótica (DIRETRIZ, 2020). Todas as medidas subsequentes devem ser realizadas no braço com valores mais elevados da PA (DIRETRIZ, 2020).



CLASSIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL - ADULTOS

Quadro 3.4 – Classificação da pressão arterial de acordo com a medição no consultório a partir de 18 anos de idade

Classificação*	PAS (mmHg)	e	PAD (mmHg)
PA ótima	< 120	e	< 80
PA normal	120-129	e/ou	80-84
Pré-hipertensão	130-139	e/ou	85-89
HA Estágio 1	140-159	e/ou	90-99
HA Estágio 2	160-179	e/ou	100-109
HA Estágio 3	≥ 180	e/ou	≥ 110

TÉCNICAS DE AFERIÇÃO DE PA - CRIANÇA

→ A medida da PA na criança segue as mesmas recomendações da medida em adultos.

→ Sendo preferencial o braço direito, para ser comparável com as tabelas padrão e evitar falsas medidas baixas no braço esquerdo no caso de Coarctação da Aorta.

→ Medir a circunferência do braço para a escolha do manguito:

- 1º passo: Medir a distância do acrômio ao olécrano,
- 2º passo: Identificar o ponto médio da distância entre o acrômio e o olécrano;
- 3º passo: Medir a circunferência do braço nesse ponto médio. A partir dessa medida, seleciona-se o manguito adequado para a medida, que deve cobrir 40% da largura e 80 a 100% do comprimento.



EM QUEM MEDIR? Todas as crianças maiores de 3 anos devem ter a sua pressão arterial medida pelo menos uma vez por ano. Para as crianças menores de 3 anos, a avaliação da PA está indicada em condições especiais.

CLASSIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL - CRIANÇAS

→ Considera-se Hipertensão Arterial na Infância e Adolescência, valores de pressão arterial sistólica e/ou diastólica iguais ou superiores ao Percentil 95 para sexo, idade e percentil da altura em três ou mais ocasiões diferentes.

→ Aumento da prevalência, associação com sobrepeso e obesidade.

Crianças de 1 a 13 anos de idade

Normotensão:

PA $< P90$ para sexo, idade e altura

Pressão arterial elevada:

PA $\geq P90$ e $< P95$ para sexo, idade e altura ou PA 120/80 mmHg mas $< P95$ (o que for menor)

Hipertensão estágio 1:

PA $\geq P95$ para sexo, idade e altura até $< P95 + 12$ mmHg ou PA entre 130/80 o até 139/89 (o que for menor)

Hipertensão estágio 2:

PA $\geq P95 + 12$ mmHg para sexo idade ou altura ou PA $\geq$ entre 140/90 (o que for menor)

→ Se à primeira medida, a PA for $= P90$, deve-se medir mais 2 vezes na mesma visita e calcular a média das 3 medidas. Essa média deve ser usada para avaliação do estadiamento da pressão arterial.

→ A hipertensão com causa secundária é mais frequente em crianças.

Estratificação de risco do sistema cardiovascular

→ Está amplamente estabelecida a relação causal, linear e contínua entre o aumento da pressão arterial (PA) e o risco de doença cardiovascular (DCV) em ambos os sexos, todas as idades e todos os grupos étnicos.

→ A classificação do risco CV depende dos níveis da PA, dos FRCV associados, da presença de lesões em órgãos-alvo (LOA), que são lesões estruturais e/ou funcionais decorrentes da HA em vasos, coração, cérebro, rins e retina, e/ou da existência de DCV ou doença renal estabelecidas.



Quadro 5.4 – Classificação dos estágios de hipertensão arterial de acordo com o nível de PA, presença de FRCV, LOA ou comorbidades

FR: presença de LOA ou doença	PA (mmHg)			
	Pré-hipertensão PAS 120-139 PAD 85-89	Estágio 1 PAS 140-159 PAD 90-99	Estágio 2 PAS 160-179 PAD 100-109	Estágio 3 PAS ≥ 180 PAD ≥ 110
Sem FR	Sem risco adicional	Risco baixo	Risco moderado	Risco alto
1 ou 2 FR	Risco baixo	Risco moderado	Risco alto	Risco alto
≥ 3 FR	Risco moderado	Risco alto	Risco alto	Risco alto
LOA, DRC estágio 3, DM, DCV	Risco alto	Risco alto	Risco alto	Risco alto

PA: pressão arterial; FR: fator de risco; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; LOA: lesão em órgão-alvo; DRC: doença renal crônica; DM: diabetes mellitus.

Exame Físico do Sistema Cardiovascular

→ O exame físico do coração inclui a inspeção, a palpação e a ausculta

INSPEÇÃO E PALPAÇÃO

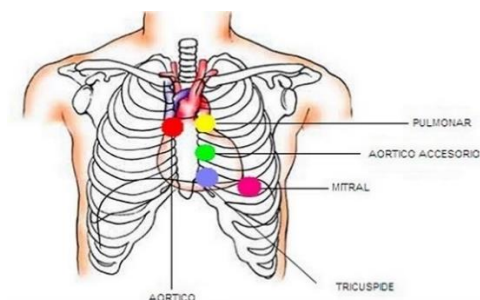
- Pesquisa de abaulamento. É a dilatação do VD que determina o abaulamento.



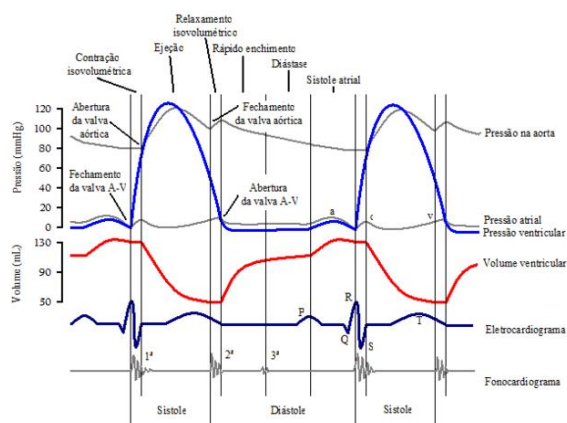
Diferença entre abaulamento por alteração de estrutura osteomuscular do abaulamento causado pelo crescimento do VD: ocorrência de impulsão do precórdio, que parece nos casos de hipertrofia

- Análise do ictus cordis ou choque de ponta. Investiga-se localização, mobilidade, intensidade.
- Pesquisa de frêmito cardiovascular. Sensação tátil determinada por vibrações produzidas no coração ou nos vasos. Correspondem aos sopros.

AUSCULTA



BULHAS CARDÍACAS



- B1: fechamento das válvulas atrioventriculares "TUM"
- B2: fechamento das válvulas semilunares "TÂ"
- Desdobramento fisiológico da 2ª bulha: a válvula pulmonar sofre um retardo, principalmente durante a inspiração (a sístole do VD se prolonga), esse retardo é suficiente para perceber os dois componentes, aórtico e pulmonar, com nitidez "TLA"
- B3: enchimento ventricular rápido. Ruído protodiastólico.
- B4: contração atrial. Ocorre no fim da diástole ou pré-sístole.

Insuficiência Cardíaca

→ A IC pode ser determinada de acordo com a fração de ejeção (preservada, intermediária e reduzida), a gravidade dos sintomas (classificação funcional da New York Heart Association – NYHA) e o tempo e progressão da doença (diferentes estágios)

CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM A FRAÇÃO DE EJEÇÃO	
IC com fração de ejeção reduzida	FEVE < 40%
IC com fração de ejeção intermediária ou levemente reduzida	FEVE = 40 A 49%
IC com fração de ejeção preservada	FEVE ≥ 50%
IC com fração de ejeção melhorada	FEVE prévia < 40% e tiveram um aumento de 10 pontos percentuais atingindo taxas acima de 40%

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	
CLASSE NYHA	DESCRIÇÃO
I ASSINTOMÁTICO	Sem limitações para realização de atividade física. Atividades habituais não causam dispnéia, cansaço, palpitações.
II SINTOMAS LEVES	Discreta limitação para realização de atividade física. Atividades habituais causam dispnéia, cansaço, palpitações.
III SINTOMAS MODERADOS	Importante limitação para realização de atividade física. Atividades de intensidades inferiores causam dispnéia, cansaço, palpitações.
IV SINTOMAS GRAVES	Limitações para realização de qualquer atividade física. Sintomas de IC em repouso.

ESTÁGIOS DA IC	
ESTÁGIO	DESCRIÇÃO
A	Risco de desenvolver IC. Sem doença estrutural ou sintomas de IC.
B	Doença estrutural cardíaca presente. Sem sintomas de IC.
C	Doença estrutural cardíaca presente. Sintomas prévios ou atuais de IC.
D	IC refratária ao tratamento clínico. Requer intervenção especializada.



CLASSIFICAÇÃO DE ROSS PARA CRIANÇAS E LACTENTES	
CLASSES	INTERPRETAÇÃO
I	Pacientes assintomáticos
II	Lactentes: taquipneia leve ou sudorese às mamadas; sem atraso do crescimento. Crianças maiores: dispneia aos exercícios
III	Lactentes: taquipneia importante ou sudorese às mamadas, tempo de mamada prolongado; atraso do crescimento. Crianças maiores: dispneia importante aos exercícios
IV	Pacientes sintomáticos em repouso: taquidispneia com tiragem intercostal, gemidos e sudorese em repouso

SINAIS E SINTOMAS DA IC

TIPOS DE DISPNEIA

Ortopneia é a dispneia que impede o paciente de ficar deitado e o obriga a sentar-se ou a ficar de pé para obter algum alívio.

Trepopneia é a dispneia que aparece em determinado decúbito lateral, como acontece nos pacientes com derrame pleural que se deitam sobre o lado sadio.

A platipneia (contrário da ortopneia) é a dispneia que aparece quando o paciente passa da posição deitada para sentado ou em pé. As causas mais frequentes são malformação arteriovenosa pulmonar, síndrome hepatopulmonar, forame oval patente ou um defeito no septo atrial (shunt direita-esquerda intracardíaco).

SINAIS E SINTOMAS DA IC
SINTOMAS TÍPICOS
Falta de ar/dispneia
Ortopneia
Dispneia paroxística noturna
Fadiga/cansaço
Intolerância ao exercício
SINAIS MAIS ESPECÍFICOS
Pressão venosa jugular elevada
Refluxo hepatojugular
Terceira bulha cardíaca
Impulso apical desviado para a esquerda (ictus cordis)

SINAIS E SINTOMAS DE BAIXO DÉBITO CARDÍACO

PAS < 90 mmHg
PAS < 110 mmHg em pacientes previamente hipertensos
Fadiga
Extremidades frias com perfusão reduzida (> 3 segundos é anormal)
Sudorese fria
Desorientação

CRITÉRIOS DE FRAMINGHAM – IC AGUDA

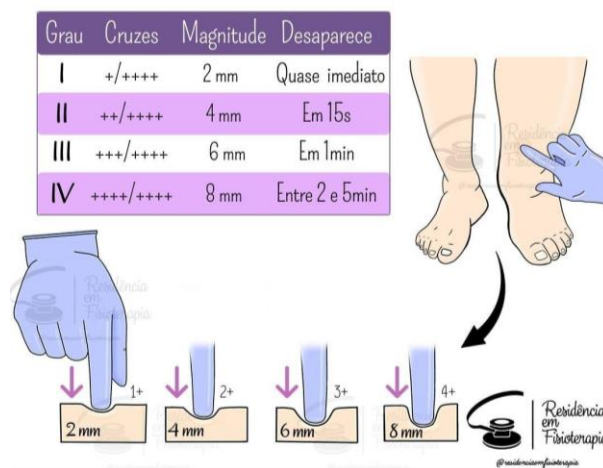
CRITÉRIOS MAIORES	CRITÉRIOS MENORES
Dispneia paroxística noturna	Edema de tornozelo bilateral
Turgência jugular a 45°	Tosse noturna
Refluxo hepatojugular	Dispneia aos mínimos esforços
Estertores pulmonares crepitantes	Derrame pleural
Cardiomegalia ao raio X de tórax	Taquicardia
Edema pulmonar agudo	
Golpe de terceira bulha	

→ Refluxo hepatojugular: comprimir o hipocôndrio direito com a cabeça do paciente elevada em 45°. Durante a compressão, deve observar se ocorre o aumento do volume e turgência da veia jugular externa, e se presente indica a congestão sistêmica.



→ Sinal de Cacifo: avaliar a presença de edema. Comprimir estruturas ósseas, avaliar bilateralmente.

Sinal de Cacifo (ou Godet)



IMPORTANTE: As crianças podem apresentar as seguintes manifestações clínicas: gemidos, pulso fino, baixo ganho de peso.

Dor torácica

→ A dor torácica aguda é uma das causas mais frequentes de atendimento nas unidades de emergência.

→ O sintoma de dor torácica constitui um grande desafio para o médico da emergência em decorrência da ampla lista de diagnósticos diferenciais.

→ Os cinco principais grupos de etiologias de dor torácica, por ordem decrescente de prevalência, são as causas musculoesqueléticas, gastrointestinais, cardíacas, psiquiátricas e pulmonares.



Tabela 3. Característica da dor torácica.

	Típica	Atípica
Caráter da dor	Construção Compressão Queimação Peso Dor surda	Facada, agulhada Pontada Piora ao respirar Aguda
Localização da dor	Retroesternal Ombro esquerdo Pescoço Face, dentes Região interescapular Epigástrica	Ombro direito Hemitórax direito
Fatores desencadeantes	Exercício Excitação Estresse Frio Refeições copiosas	Ao repouso

→ Diferentemente da população adulta, a dor torácica na infância raramente representa uma doença grave.

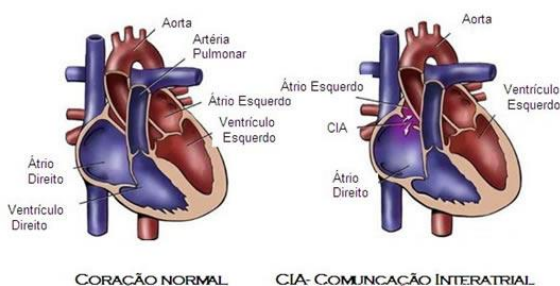
Crianças: musculoesquelética, gastrointestinal
Adolescentes: psicogênica

SINAL DE FRANK: prega lobular – avançar da idade

Cardiopatas congênitas

- **ACIANÓTICAS:** shunt esquerda para direita Hiperfluxo pulmonar. Ex: CIA, CIV, PCA
- **CIANÓTICAS:** shunt direita para esquerda Cianose/IC. Ex: Tetralogia de Fallot, Transposição de Grandes Vasos

COMUNICAÇÃO INTERTRIAL – CIA

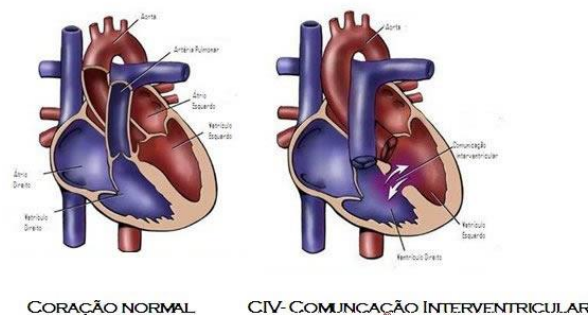


- Desdobramento fixo da B2 (TRÁ);
- Sopro sistólico de ejeção em borda esternal esquerda média alta (BEEM-A) / Fo. Pulmonar: estenose relativa;
- Sinais de IC.

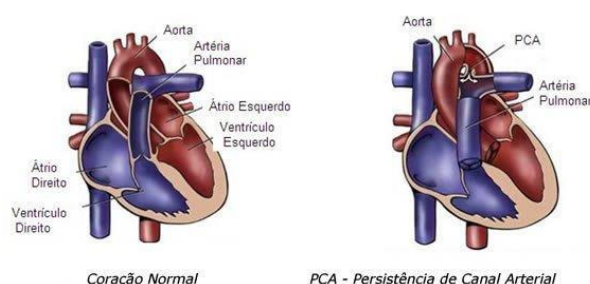
COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR – CIV

- Sinais de IC;
- Abaulamento precordial esquerdo - desvio de ictus
- < CIV > SOPRO – maior turbilhonamento para passar por um espaço pequeno.
- Sopro holossistólico em BEEB;
- Frêmito paraesternal E;

- Assintomáticos: CIV pequena

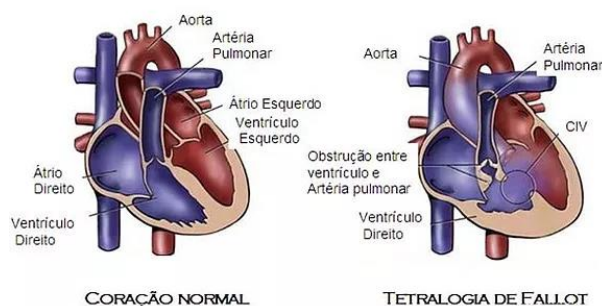


PERSISTÊNCIA DO CANAL ARTERIAL – PCA



- IC moderada/grave;
- Sopro na sístole e diástole (lembra o trem – mais forte na sístole);
- Pulsos amplos;
- PA divergente (> 40 mmHg);
- Sopro infraclavicular E com irradiação para dorso, contínuo (em maquinaria);
- Precórdio hiperdinâmico;
- B2 hiperfonética

TETRALOGIA DE FALLOT (T4F)



- Cianose progressiva;
- Baqueteamento digital;
- Sopro sistólico ejetivo BEEM-A (diminui na crise de hipóxia)
- Crise de hipóxia: emergência

Sopro na infância

→ Achado frequente durante o exame pediátrico;



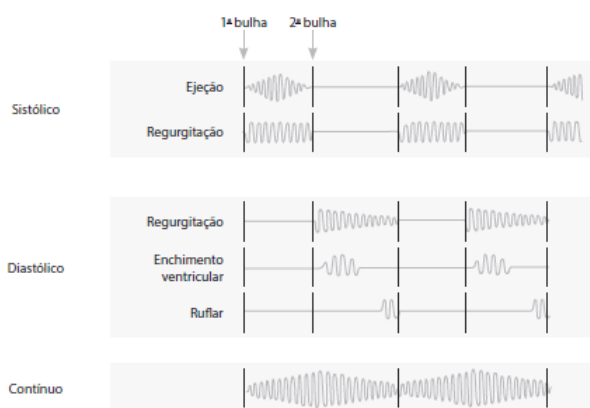
→ Avaliação do sopro cardíaco: posição no ciclo cardíaco, características, intensidade, localização

SOPRO INOCENTE

- Estados hiper cinéticos (ex.: febre);
- Sistólicos, suave, curta duração;
- Nunca são diastólicos;
- Sem ruídos acessórios/frêmitos;
- Bulhas sempre normais;
- Bem localizados, sem irradiação;
- Alteração com mudança de decúbito

TIPOS DE SOPRO

Localização durante o ciclo



Intensidade do sopro

→ A intensidade do sopro pode ser descrita de forma subjetiva e classificada em graus que variam de I a VI.

- Os graus I e II são sopros de fraca intensidade, sendo que o grau I só é detectado por meio de ausculta muito cuidadosa
- Sopros graus III e IV são sopros de intensidade moderada, sendo que o grau IV apresenta frêmito palpável
- Sopros graus V e VI são intensos, vêm acompanhados de frêmitos, sendo que o grau VI pode ser audível mesmo sem o estetoscópio

LOCALIZAÇÃO DOS FENÔMENOS ESTETOACÚSTICOS

Quando se faz a ausculta do coração e se encontram outros sons que não sejam as bulhas, cumpre localizá-los exatamente na revolução cardíaca, tomando por base a 1ª e a 2ª bulha. Para isso, dividem-se a sístole e a diástole nas seguintes partes:

- Protossístole = terço inicial da sístole
- Mesossístole = terço médio da sístole
- Telessístole = terço final da sístole
- Protodiástole = terço inicial da diástole
- Mesodiástole = terço médio da diástole
- Telediástole = terço final da diástole

Teste do coraçãozinho

→ É um método de triagem cardiológica universal, não invasiva, de forma instantânea e sem necessidade de calibração. Além de apresentar sensibilidade de 75% e especificidade de 99%.

→ O teste do Coraçãozinho consiste em um exame de triagem neonatal que visa o diagnóstico precoce das cardiopatias congênitas graves, ou seja, aquelas onde há risco de vida imediato e que precisam de intervenção cirúrgica precocemente.

→ É realizado no período neonatal, após as primeiras 24 horas de vida e antes da alta hospitalar, através de um aparelho chamado de oxímetro de pulso, o qual avalia o nível de saturação de oxigênio.

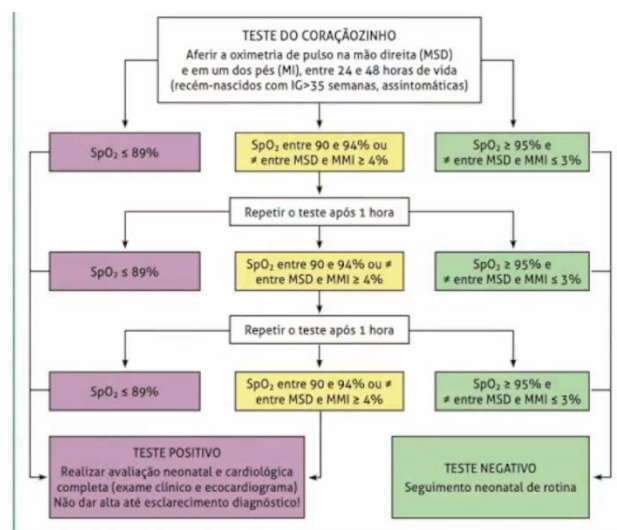
→ O oxímetro deve ser colocado primeiramente na mão direita e posteriormente em um dos pés do bebê, para verificação de níveis de oxigênio.



ATUALIZAÇÃO DO FLUXOGRAMA

→ A primeira mudança está no público rastreado, agora recém-nascidos com mais de 35 semanas.

→ Eles diminuíram o valor de corte de SatO2 de 95% para 89% para considerar um teste positivo. Além disso, agora existe a possibilidade do teste ser considerado duvidoso, que não existia no fluxograma antigo.



→ Um grupo intermediário foi criado com valores de corte de SatO₂ entre 90 e 94% OU diferença entre as medidas maior ou igual a 4%. É justamente os recém-nascidos que se encaixam nesse grupo na primeira oximetria de pulso que tem o teste considerado duvidoso e devem ser reavaliados com 1 hora. Se mantiver os parâmetros, um terceiro teste deve ser feita em 01 hora.

→ Se no terceiro teste mantiver satO₂ entre 90 e 94% ou diferença entre as medidas maior ou igual a 4%, o teste é considerado positivo. Se em algum desses testes adicionais a satO₂ ficar menor que 89% o teste já é considerado positivo. Se der SatO₂ > 95% e diferença <4%, o teste é considerado negativo.

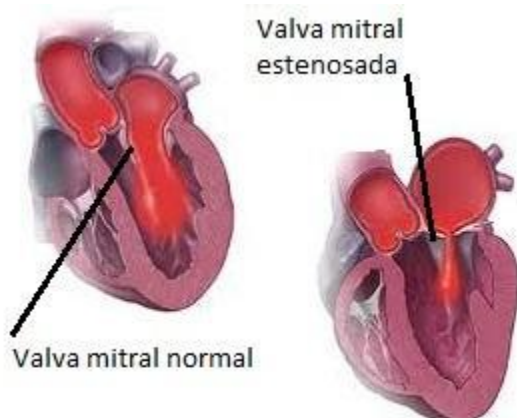
Pulsos

- Pulso célere ou em martelo d'água: sua característica fundamental é que aparece e some com rapidez, lembrando a sensação tátil provocada pelo martelo d'água.
- Pulso pequeno ou parvus: a tensão do pulso apresenta-se diminuída, e o pulso parece fraco e pequeno.
- Pulso filiforme: é um tipo de pulso ao mesmo tempo de pequena amplitude e mole.
- Pulso alternante: percebe-se de modo sucessivo uma onda ampla seguida de outra mais fraca.
- Pulso paradoxal: acentuada redução inspiratória da amplitude do pulso.

Valvopatias

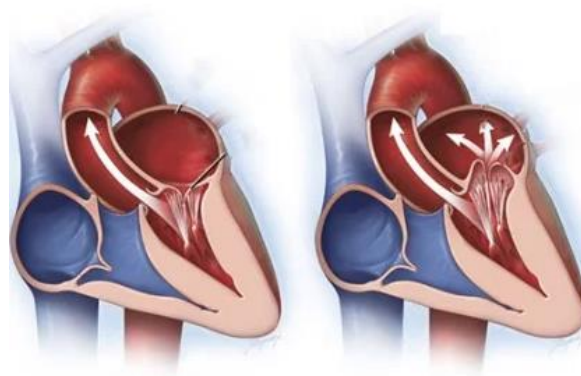
→ Ainda que qualquer uma das quatro valvas possa estar sujeita a um distúrbio, as mais comumente afetadas são as valvas mitral e aórtica.

ESTENOSE MITRAL



- Facies mitralis – rubor cor de ameixa nas bochechas;
- B1 e B2 hiperfonéticas;
- Sopro diastólico em ruflar – pode irradiar para axila ou borda esternal esquerda inferior;
- Sinais de congestão pulmonar e insuficiência cardíaca direita.

INSUFICIÊNCIA MITRAL



- Ictus cordis desviado para a esquerda e para baixo;
- B1 hipofonética;
- B2 hiperfonética;
- Sopro sistólico regurgitativo;
- Sinais clínicos de IC direita;

ESTENOSE AÓRTICA

- Pulso parvus et tardus;
- Sopro sistólico ejetivo;
- Hipofonese de B1 e B2;
- Fenômeno de Gallavardin – sopro de estenose aórtica se irradia para o foco mitral – vibração do anel;
- Desdobramento paradoxal de B2 ou B2 única.

INSUFICIÊNCIA AÓRTICA



- Sopro diastólico aspirativo decrescente;
- B2 hipofonética;
- Sopro de Austin-Flint – estenose mitral relativa a uma insuficiência aórtica, fluxo e pressão do jato maior atinge a 1ª válvula da valva mitral, logo, restringe a abertura da sua valva anterior;
- Pulso em martelo d'água;
- PA divergente;
- Sinais clínicos de aumento de pressão de pulso: Sinal de Musset (cabeça), Sinal de Quincke (unha).



Sinais Vitais – SSVV

→ PA, FC, FR, Saturação, Temperatura e Dor.

FREQUÊNCIA CARDÍACA – FC

- Adultos: 50-100 bpm

OBS.: Casos que deve-se aferir a FC pela ausculta – IC com baixo débito, arritmia e FA

FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA – FR

- Adultos: 12-20 rpm – tolera-se até 24 rpm

FR NORMAL PARA CRIANÇAS

ATÉ 2 MESES	Até 60 mrm
2-11 MESES	Até 50 mrm
1-4 ANOS	Até 40 mrm

SATURÇÃO – SPO2

- Normalidade: 95-100%

Oxímetro: avalia a saturação periférica;
Gasometria: saturação mais precisa

→ A aferição da SPO2 sofre influencia com esmalte escuro, extremidades frias

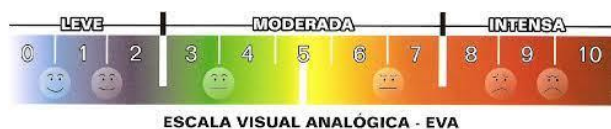
→ Gestantes hipoxêmicas tem risco de causar sofrimento fetal e aborto

TEMPERATURA

- Febre: maior ou igual a 37,8 °C
- Subfebril: 37,5 °C

OBS.: Em crianças é importante avaliar a disposição

ESCALA DA DOR



Referência e Contrarreferência

→ A Referência diz respeito ao encaminhamento do usuário a um atendimento com níveis de especialização mais complexos, os hospitais e as clínicas especializadas

→ A Contrarreferência ocorre quando a necessidade do usuário mais complexa é sanada e a necessidade se torna mais simples. Então ele é reencaminhado para uma unidade de menor complexidade, ou seja, deve ser conduzido à Unidade Básica de Saúde mais próxima a sua residência

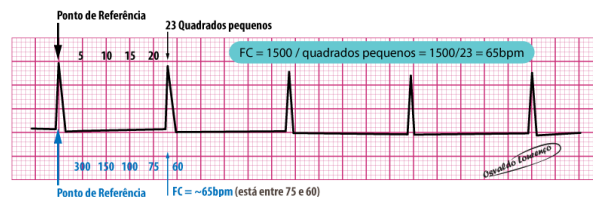
Electrocardiograma

- Identificação;
- Ritmo;

Analisar se o ritmo é sinusal: verificar presença de onda P positiva em DI, DII, aVF, com intervalo R-R regular.

- FC;

Cálculo da FC: 1500/pelo nº de quadradinho entre R-R



- Eixo;

Eixo normal: entre -30° - + 90°

DI + e aVF +: eixo entre 0 e +90°

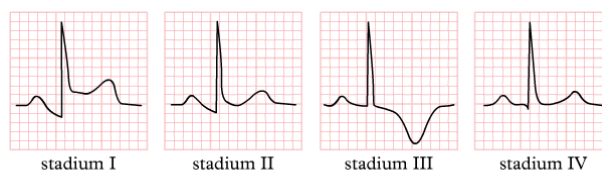
Se DI + e aVF negativo: avaliar DII (Se DII positivo, eixo normal, se DII negativo eixo alterado)

Pericardite na infância

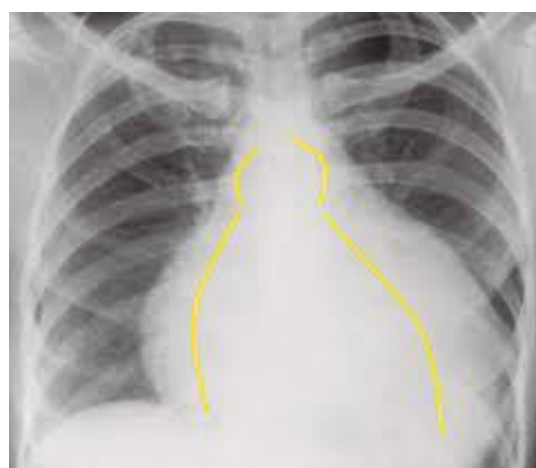
- Dor precordial – pode ser aliviada na posição genupeitoral;
- Febre de graus variáveis;
- Atrito pericárdico – sinal cardinal;
- Pulso paradoxal;
- SINAIS DE TAMPONAMENTO CARDÍACO: bulhas cardíacas hipofonéticas, hipotensão, pressão na jugular elevada – TRIADE DE BECK

EXAMES

ELETCARDIOGRAMA



RADIOGRAFIA DE TÓRAX



Trombose Venosa Profunda

→ Quando presentes, os sinais e sintomas mais comuns são aqueles relacionados ao processo inflamatório, incluindo dor, edema (geralmente, unilateral) e sensibilidade em músculos profundos

→ Hiperpigmentação, dermatite de estase ou ocre: no terço inferior do membro acometido - acúmulo crônico de hemossiderina na derme

→ Úlcera: bordas mal delimitadas, apresentando constantemente secreção serosa ou seropurulenta, fundo róseo. Localiza-se, principalmente, na região maleolar medial podendo o tecido adjacente estar hiperpigmentado. É menos dolorosa e melhora com a elevação do membro acometido.

TVP DO SEGMENTO AXILOSUBLÁVICO – SÍNDROME DE PAGET-SCHROEDER



SINAIS E MANOBRAS



Sinal de Brancoft



Sinal de Bandeira



Manobra de Homans

OBS.: Todos esses sinais clínicos podem ocorrer na TVP, porém eles não apresentam boa sensibilidade e especificidade

ESCORES DE WELLS

ESCORE DE WELLS PARA TVP	
VARIÁVEL CLÍNICA	PONTUAÇÃO
Câncer ativo (tratamento atual ou nos últimos 6 meses ou em cuidados paliativos)	+1

Paralisia, parestesia ou imobilização recente dos membros inferiores	+1
Acamado tempo maior ou igual há 3 dias ou cirurgia maior nas últimas 12 semanas	+1
Dor localizada no trajeto do sistema venoso profundo	+1
Edema de todo membro inferior	+1
Edema de panturrilha com pelo menos 3 cm de diâmetro maior do que a outra perna	+1
Edema compressivo (cacifo) apenas na perna sintomática	+1
Veias colaterais superficiais (não varicosas)	+1
TVP prévia documentada	+1
Diagnóstico alternativo mais provável que TVP	-2

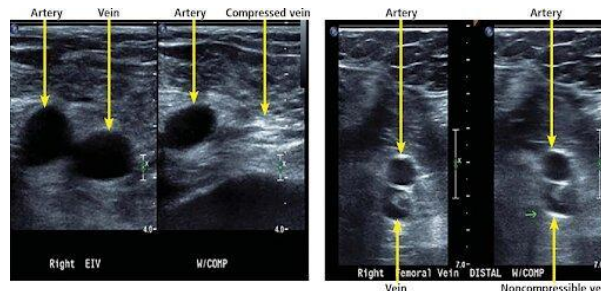
CLASSIFICAÇÃO DE PROBABILIDADE DO ESCORE DE WELLS PARA TVP EM 3 NÍVEIS

BAIXA	INTERMEDIÁRIA	ALTA
< 1 ponto	1-2 pontos	> 2 pontos

CLASSIFICAÇÃO DE PROBABILIDADE DO ESCORE DE WELLS PARA TVP EM 2 NÍVEIS (WELLS MODIFICADO)

IMPROVÁVEL	PROVÁVEL
Menor ou igual a 1 ponto	Maior ou igual a 2 pontos

ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER



D-DÍMERO

→ O exame de laboratório mais útil para a TVP é a dosagem do Dímero D, metabólito resultante da degradação da fibrina, um importante indicador de fibrinólise. Seus valores de referência são > 500 ug/L para resultado positivo e < 350 ug/L para resultados negativos, podendo alterar-se com a idade.

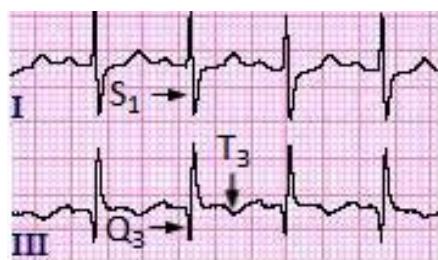
→ Para a confirmação diagnóstica, o mais recomendado nos casos de baixa probabilidade pré-teste pelo escore de Wells é fazer a dosagem de Dímero D, caso dê um resultado negativo, a TVP é excluída. Se o Dímero D estiver elevado, fazer exame de imagem; se for positivo, o diagnóstico é confirmado.

Tromboembolismo Pulmonar

- Dispneia súbita;
- Dor torácica, especialmente pleurítica;
- Taquicardia;
- Síncope;
- Taquipneia - > 20rpm



ECG



Taquicardia sinusal. No entanto, o padrão "S1Q3T3" de cor pulmonale agudo é clássico.

The S₁Q₃T₃ pattern
LearnTheHeart.com

ACHADOS RADIOLÓGICOS

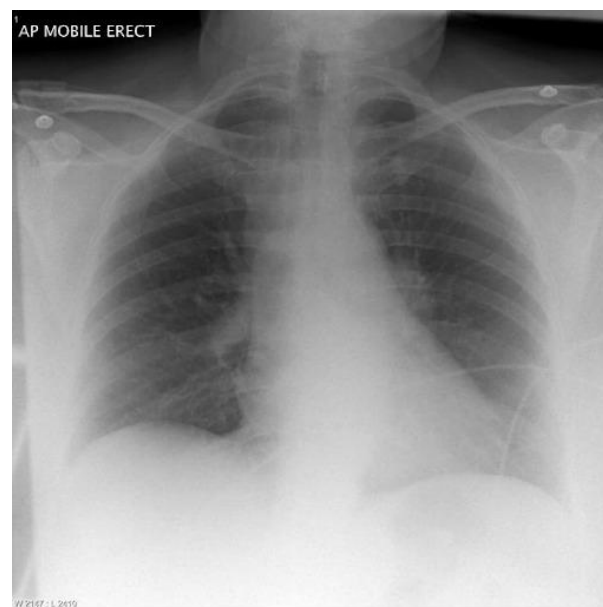
Corcova de Hampton: imagens hipotransparentes em formato de cunha em bases pulmonares referentes à área de infarto pulmonar.



Sinal de Westermark: áreas de hipoperfusão pulmonar com diminuição da trama vascular.



Sinal de Palla: dilatação da artéria pulmonar.



Atelectasia: Quando os alvéolos pulmonares sofrem um colapso, se fechando e ficando sem ar em seu interior.



Atelectasia do lobo superior direito

OBS.: Raio-x é importante para o diagnóstico diferencial

CRITÉRIOS DE WELLS E GENEBRA MODIFICADO

Genebra modificado	Pontos	Wells	Pontos
TVP ou EP prévios	+3	TVP ou EP prévios	+1,5
Câncer ativo	+2	Frequência cardíaca > 100/min	+1,5
Cirurgia recente ou fratura no último mês	+2	Cirurgia recente ou imobilização	+1,5
Idade > 65 anos	+1	Sinais clínicos de TVP	+3
Dor na perna unilateral	+3	Diagnóstico alternativo menos provável que EP	+3
Hemoptise	+2	Hemoptise	+1
Frequência cardíaca entre 75-94 bpm	+3	Câncer	+1
Frequência cardíaca ≥ 95 bpm	+5		
Edema unilateral da perna ou dor à palpação de trajeto venoso	+4		
BAIXA PROBABILIDADE	0 a 3	BAIXA PROBABILIDADE	0 a 1
INTERMEDIÁRIA PROBABILIDADE	4 a 10	INTERMEDIÁRIA PROBABILIDADE	2 a 6
ALTA PROBABILIDADE	≥ 11	ALTA PROBABILIDADE	≥ 7



Exame Físico do Sistema Respiratório

→ O exame físico do sistema respiratório é composto por inspeção, palpação, percussão e ausculta

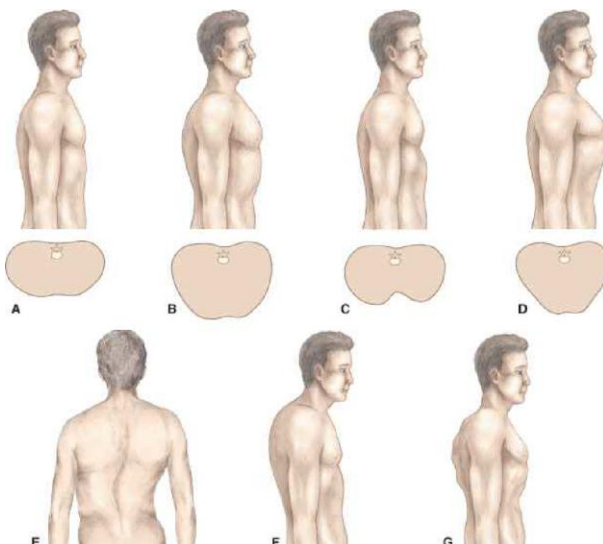
INSPEÇÃO

INSPEÇÃO ESTÁTICA

- Coloração e grau de hidratação da pele;
- Retrações ou abaulamentos;
- Enchimento capilar – até 3 segundos;
- Edema de MMI;
- Baqueteamento digital;



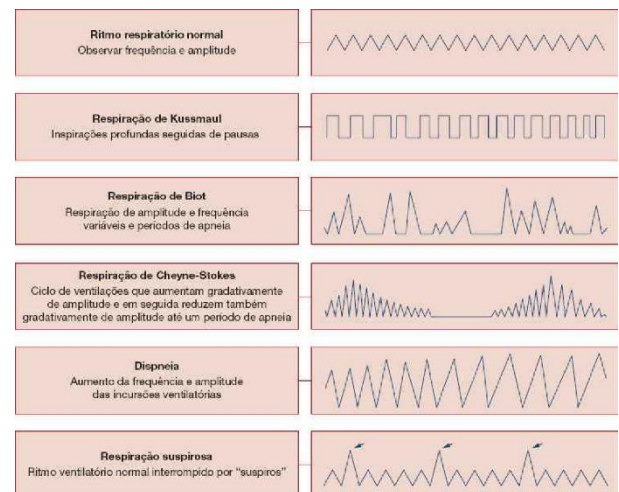
- Forma do tórax;



INSPEÇÃO DINÂMICA

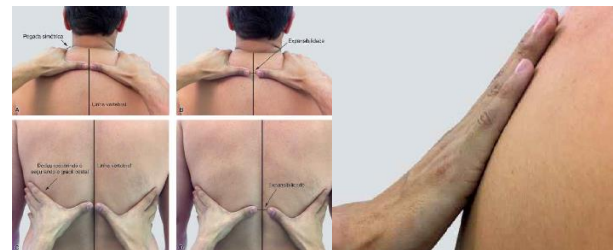
- Batimento de asas do nariz;
- Uso de musculatura acessória
- FR: 12- 20 rpm

RITMO RESPIRATÓRIO

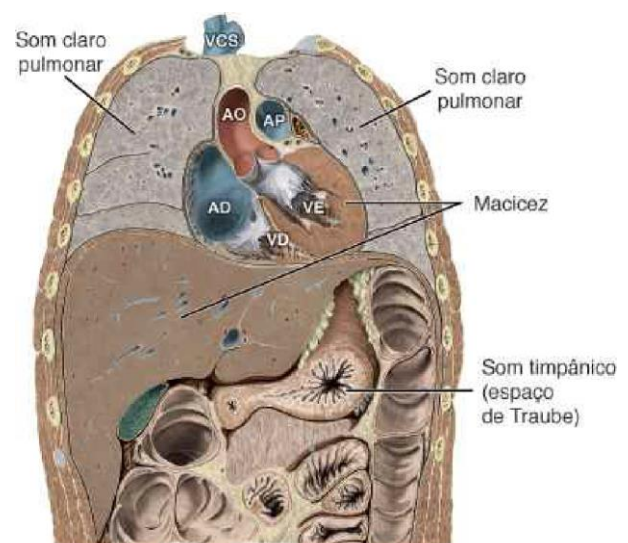


PALPAÇÃO

- Temperatura cutânea – dorso da mão;
- Edema e enfisema subcutâneos;
- Linfonodos regionais;
- Expansibilidade pulmonar;
- Frêmito toracovocal;



PERCUSSÃO



→ Quatro tonalidades de som são obtidas:

- som claro pulmonar ou sonoridade pulmonar nas áreas de projeção dos pulmões;
- som timpânico no espaço de Traube;



- som maciço na região inferior do esterno (macicez hepática),
- som maciço na região inframamária direita (macicez hepática) e submaciço na região precordial

AUSCULTA

→ Os sons pleuropulmonares podem ser assim classificados:

SONS NORMAIS: Som traqueal; Som brônquico; Murmúrio vesicular; Som broncovesicular.

SONS ANORMAIS: Descontínuos: estertores finos e grossos; Contínuos: roncos, sibilos e estridor; Sopros

SONS VOCALIS: Broncofonia, egofonia, pectorilóquia fônica e afônica

Tuberculose

- Manifestações sistêmicas: febre, mal-estar, sudorese noturna, fadiga e perda de peso.
- Manifestações locais: dispneia, tosse seca ou com expectoração, hemoptise

TUBERCULOSE PRIMÁRIA: mais comum em crianças e adolescentes
TUBERCULOSE PÓS-PRIMÁRIA

OBS.: As crianças desenvolvem com mais frequência as formas extrapulmonares ou disseminadas da doença

- Creptações na ausculta, quando a consolidação pulmonar é próxima da parede torácica
- Sopro tubário ou anafórico.

DIAGNÓSTICO

- BAAR – espontâneo ou induzido
- Teste de biologia molecular – PCR: resultado em até 2 horas, pode utilizar líquido, lavado gástrico.
- Cultura: demora cerca de 6 a 8 semanas
- Radiografia de tórax

Tuberculose primária: consolidações de resolução lenta, especialmente com linfadenomegalias hilares

Tuberculose pós-primária: consolidação com predomínio nos lobos pulmonares superiores

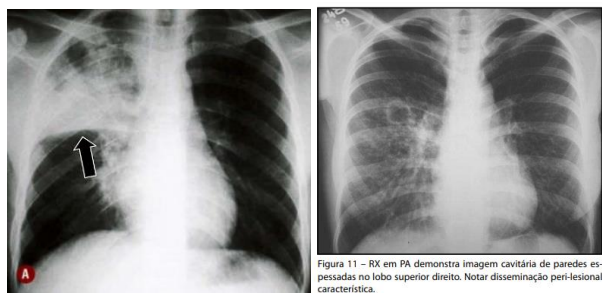


Figura 11 – RX em PA demonstra imagem cavitária de paredes espessadas no lobo superior direito. Notar disseminação peri-lesional característica.



TB latente: PPD e Raio-x de tórax

IMPORTANTE: crianças definir se é maior ou menor de 10 anos, pois crianças com mais de 10 anos de idade geralmente evolui para a tuberculose ativa do tipo adulto.

Tratamento: Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Em crianças não utiliza-se o etambutol.

BCG

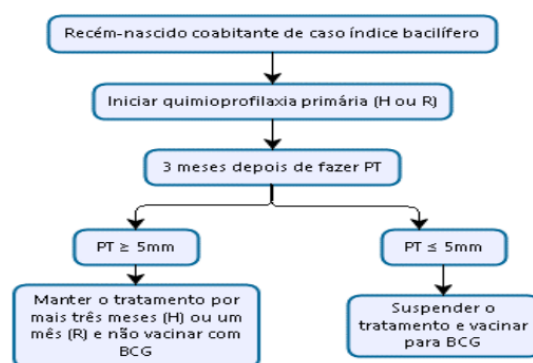
→ A vacina BCG é indicada para crianças até os 4 anos, 11 meses e 29 dias para prevenir as formas graves da tuberculose, como a meningoencefalite tuberculosa e a tuberculose miliar.

→ Não há recomendação de revacinar crianças que foram vacinadas com a vacina BCG e que não apresentem cicatriz vacinal independentemente do tempo transcorrido após a vacinação

→ O esquema de vacinação com a vacina BCG corresponde à aplicação de dose única o mais precocemente possível após o nascimento. A administração da vacina BCG deve ser adiada quando a criança apresentar peso inferior a 2 kg ou quando apresentar lesões graves de pele. A administração da vacina é intradérmica, no braço direito, na altura da inserção do músculo deltoide, essa localização permite fácil verificação da existência de cicatriz

IMPORTANTE: A tuberculose é uma doença de notificação compulsória

PUERPÉRIO E TUBERCULOSE



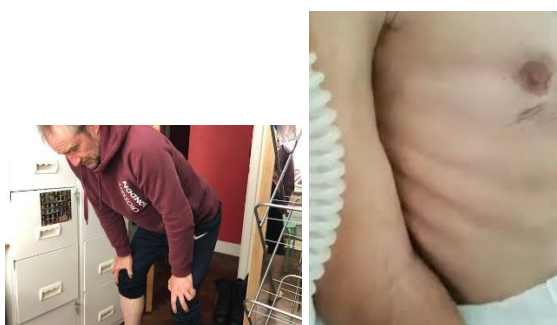
- Sempre amamentar.

Mãe com tuberculose: Está tratando há mais de 2 semanas?

- SIM: Segue a vida normal
- NÃO: coloca a máscara e amamenta

Asma

- Mais de um tipo de sintoma respiratório – dispneia, tosse seca, sibilos;
- Sintomas são variáveis no tempo e na intensidade;
- Piores à noite ou ao acordar;
- Aparecem ou pioram com infecção viral;
- CRISE – posição de tripé;
- Tiragem intercostal;



ESPIROMETRIA

- $VEF_1/CVF < 70\%$ e $VEF_1 < 80\%$

IMPORTANTE: resposta positiva da espirometria com o uso de broncodilatador.

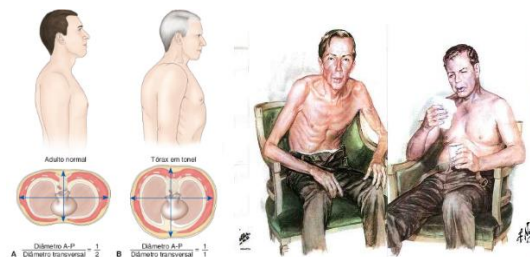
OBS.: Deve-se fazer higiene oral (c/ água) após o uso da bombinha, pois pode surgir candidíase oral

DPOC

→ Enfisema: destruição dos septos interalveolares

→ Bronquite crônica: tosse persistente produtiva por, no mínimo, 3 meses em pelo menos 2 anos consecutivos

- Fadiga, tosse, intolerância ao exercício.
- Pink puffers – sopradores rosados: enfisema Ausência de cianose, ao uso de músculos acessórios e à respiração com os lábios semicerrados ("soprador") O ar permanece retido nos alvéolos e pulmões, provocando aumento das dimensões anteroposteriores do tórax, o chamado tórax em tonel ou barril, típico de pessoas com enfisema Estas apresentam diminuição drástica nos sons respiratórios por todo o tórax
- Pletórico azulado: Cianose e à retenção de líquido associadas à insuficiência cardíaca direita



Carga tabágica (anos-maço): 2 maços por dia durante 20 anos = 40 anos/maço

OBS.: 1 maço = 10 cigarros Cigarros que não possuem filtros, multiplica-se o cálculo da carga tabágica por 3

ESPIROMETRIA

- $VEF_1/CVF < 70\%$ diagnóstico
- Possui um padrão semelhante a obstrução

OBS.: O hemograma pode apresentar $Ht > 55\%$, Policitemia secundária

A base do tratamento do DPOC é broncodilatador

ESCALA DE SINTOMAS

Categoria mMRC	Descrição
0	Dispneia só com grandes esforços.
1	Dispneia se andar rápido ou subir colina.
2	Anda mais devagar do que pessoas da mesma idade devido à falta de ar; ou quando caminha no plano, no próprio passo, para respirar.
3	Após andar menos de 100 metros ou alguns minutos no plano, para respirar.
4	Não sai de casa devido à dispneia.

CLASSIFICAÇÃO GOLD

Avalie sintomas e presença de exacerbações ultimo ano

Historia de Exacerbações

≥ 2/ano, ou 1 internação

0 ou 1, sem internação

C

D

A

B

mMRC 0-1
CAT < 10

mMRC ≥ 2
CAT ≥ 10

Sintomas



Derrame Pleural

- Transudato: mais comum ICC.
- Exsudato: mais comum Derrame Parapneumônico em decorrência de pneumonia

→ Dor torácica pleurítica, tosse e dispneia

EXAME FÍSICO

INSPEÇÃO: redução da expansibilidade torácica, aumento da FR

- Sinal de Lemos Torres: abaulamento expiratório intercostal
- Sinal de Litten: ausência do rebaixamento intercostal

PALPAÇÃO: redução do frêmito toracovocal (33)

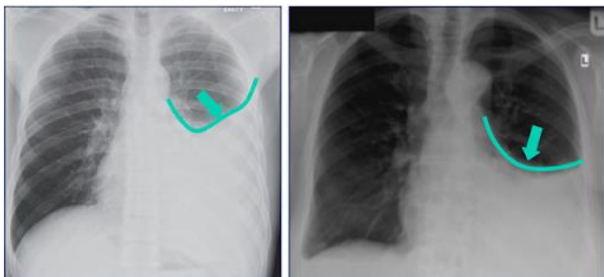
PERCUSSÃO: macicez ou submacicez na topografia do líquido

- Sinal de Signorelli: macicez à percussão da coluna vertebral

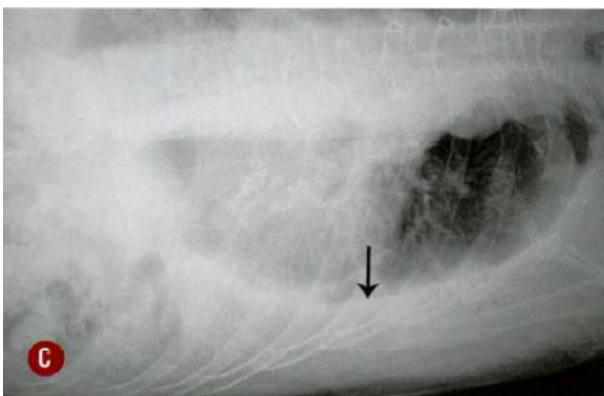
AUSCULTA: murmúrios vesiculares reduzidos. Pode ter crepitação acima da área do derrame. Egoфония – voz anasalada – coloca o estetoscópio onde acha q está o derrame (pede pra o paciente falar iii e escuta eeee).

IMPORTANTE: Após a suspeita clínica de DP é mandatório usar um exame de imagem.

RADIOGRAFIA DO TÓRAX



Sinal do menisco – parábola de damoiseau



Derrame pleural visto na incidência em decúbito lateral. O líquido acaba se depositando na região pendente, facilitando a sua identificação.

OBS.: Na suspeita de derrame pleural pequeno em decúbito dorsal, podemos utilizar a técnica de decúbito lateral com raios horizontais, podendo observar derrames a partir de 50 ml de volume.

Raio-X em PA é necessário mais que 200ml para obliterar o seio costofrênico lateral

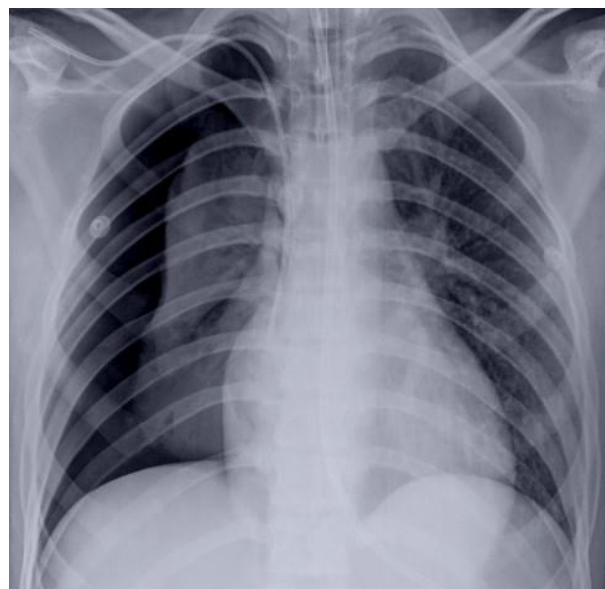
→ O DP loculado deve ser realizado a toracocentese guiada por USG.

Toracocentese diagnóstica ou terapêutica: borda superior da costela inferior. Interromper procedimento: desconforto respiratório, dor torácica, tosse ou hipotensão.

Pneumotórax

PERCUSSÃO: timpânico.

AUSCULTA: sons abolidos.



Diagnóstico diferencial de tosse na infância

- Refluxo;
- Rinite;
- Sinusite;
- Pneumonia;
- Infecções de vias aéreas superiores (IVAS)

→ Gotejamento pós-nasal – possível sinusite

OBS.: Ronco não é sinal de gravidade

OBS.: RN é comum fazer hipotermia

PNEUMONIA

- Febre, tosse produtiva, ausculta localizada
- Triade clássica: febre + tosse + taquipneia Ausência de sibilância

< 2 meses: FR ≥ 60 irpm;

2 a 11 meses: FR ≥ 50 irpm;

1 a 4 anos: FR ≥ 40 irpm.

(irpm=incursões respiratórias por minuto)

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria. Programa de Atualização em Terapêutica Pediátrica, 2016.

- Em base pode ter irritação do nervo frênico, por isso o paciente pode ter dor abdominal
- < 5 anos – principal causa é viral – Sincicial, Influenza
- Aumenta o frêmito toracovocal (FTV)
- Macicez ou submacicez;
- Crepitações

Quadro 2. Diagnósticos diferenciais de quadros que cursam com sibilância

Quadro clínico	Descrição
Asma	Doença crônica das vias aéreas caracterizada por obstrução ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou com tratamento. Clinicamente, expressa-se por episódios recorrentes de sibilância , dispneia, aperto no peito e tosse.
Bronquiolite aguda	Principalmente de etiologia viral, predomínio em lactentes. Além de sibilância , apresenta comumente, taquipneia e aumento do diâmetro antero-posterior do tórax .
Pneumonia	Não é comum , mas nas etiologias virais a pneumonia pode apresentar sibilância durante a infecção aguda.
Aspiração de corpo estranho	Pode causar sibilância uni ou bilateral . Uma história de início agudo , que não melhora com broncodilador, é um dado que auxilia no diagnóstico.
Tuberculose	Os gânglios infartados podem levar à obstrução das vias aéreas nas crianças pequenas com tuberculose e acarretar sibilância.
Pneumonia aspirativa	É causada por aspiração de líquido, conteúdo gástrico ou corpo estranho.
Fibrose cística	Doença genética que se caracteriza por muco espesso nas glândulas exócrinas, cursando com bronquite crônica. No lactente, é causa de tosse crônica e sibilância .

Observação: Em crianças com menos de 1 ano de idade, outras causas de sibilância são: insuficiência cardíaca, refluxo gastroesofágico, doença pulmonar congênita (broncodisplasia), entre outras.

→ Após o diagnóstico de PAC, a presença dos sintomas abaixo, em ordem crescente de gravidade, são critérios para classificação como pneumonia grave:

- Tiragem subcostal;
- Dificuldade para ingerir líquidos;

- Sinais de dificuldade respiratória mais grave (movimentos involuntários da cabeça, gemência e batimentos de asa do nariz);
- Cianose central

Quando internar?

- Menores de 2 meses, taquipneicos com ou sem retrações;
- Sinais de gravidade: hipoxemia, desidratação, desconforto respiratório

TRATAMENTO AMBULATORIAL: reavaliar em 48-72h

RADIOGRAFIA DE TÓRAX

→ A radiografia de tórax não deve ser realizada de rotina para o diagnóstico de pneumonia em crianças sem sinais de gravidade, sem necessidade de tratamento hospitalar, uma vez que não há evidências que altere o resultado clínico Deve ser realizada nas seguintes situações:

- Se há dúvida de diagnóstico, embora radiografia normal não exclua pneumonia e radiografia anormal pode ser interpretada como normal;
- Pneumonia com hipoxemia, desconforto respiratório, entre outros sinais de gravidade;
- Falha de resposta ao tratamento em 48 a 72h ou se piora progressiva, para verificar se há complicações (empiema, pneumotórax, escavação);
- Paciente hospitalizado (PA e perfil)

OBS.: A radiografia de tórax não deve ser realizada após tratamento de pneumonia com boa resposta clínica

→ Em que situações deve-se realizar radiografia de controle após o tratamento?

- Após 4 a 6 semanas, se história de pneumonias recorrentes, sempre no mesmo lobo; suspeita de malformação ou aspiração de corpo estranho;
- Deve ser considerado nos casos de pneumonia redonda, presença de colapso pulmonar e/ou sintomas persistentes

EM ADULTOS: Utiliza-se o CURB-65

Maus tratos na infância

→ Negligência ou abandono, abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, Síndrome de Munchusen

- Síndrome do bebê sacudido: edema de SNC, hemorragia retiniana
- Histórias discrepantes ou incompatíveis com as lesões apresentadas;
- Menores de 2 anos com suspeita: Raio-X do corpo todo

OBS.: NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DA SUSPEITA (Conselho Tutelar e SINAM)



Anemias

GRUPO POPULACIONAL	CONCENTRAÇÃO HB (D/DL)	HEMATÓCRITO (HT)
Homens	< 13	39-50%
Mulheres	< 12	36-44%
Gestantes	< 11	
Crianças 06-14 anos	< 12	
Crianças 06 meses – 06 anos	< 11	

ÍNDICES HEMATIMÉTRICOS

VCM (VOLUME CORPUSCULAR MÉDIO)	80-100 fL
HCM (HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA)	28-32 pg
CHCM (CONCENTRAÇÃO DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA)	32-35 g/dL
RDW (ÍNDICE DE ANISOCITOSE)	10-14%
RETICULÓCITOS	0,5-2%

Tabela 2: Diferentes tipos de classificações da anemia.

Quanto ao volume corpuscular médio (VCM)	Normocíticas
	Microcíticas
	Macroscíticas
Quanto Hb corpuscular médio (CHCM)	Normocrômicas
	Hipocrômicas
	Hipercrômicas
Quanto a atividade da Medula Óssea (MO)	Hiperproliferativas: quando a medula óssea tem capacidade de responder à queda de Hb;
	Hipoproliferativas: quando não há resposta medular à queda de Hb.

OBS.: A sintomatologia é variável: depende da rapidez de instalação da anemia, reserva miocárdica, coronariana, pulmonar e cerebral do paciente

IMPORTANTE: A presença de reticulócitos indica que a medula está hiperproliferativa

SINAIS E SINTOMAS

- Palidez cutaneomucosa (Hb <10);
- Taquicardia em repouso;
- Sopros sistólicos em borda esternal esquerda;
- Colôniques;
- Icterícia, esplenomegalia;
- Glossite e queilite angular;
- Petéquias;
- Deformidades ósseas face/crânio – talassemia



Figura 5.7 Anemia megaloblástica: glossite – a língua é vermelha como carne bovina e dolorosa.

Tabela 2.5 Classificação da anemia		
Microcítica, hipocrômica	Normocítica, normocrômica	Macroscítica
VCM < 80 fL	VCM = 80-95 fL	VCM > 95 fL
HCM < 27 pg	HCM ≥ 27 pg	Megaloblástica: deficiências de vitamina B ₁₂ e folato
		Não megaloblástica: abuso de álcool, hepatopatias, mielodisplasias, anemia aplásica, etc. (ver Tabela 5.10)
Deficiência de ferro	Muitas anemias hemolíticas	
Talassemias	Anemia de doença crônica (alguns casos)	
Anemia de doença crônica (alguns casos)		
Intoxicação por chumbo		
Anemia sideroblástica (alguns casos)		
	Anemia pós-hemorragia aguda	
	Nefropatias	
	Deficiências mistas	
	Insuficiência da medula óssea (p. ex., pós-quimioterapia, infiltração por carcinoma, etc.)	

HCM, hemoglobina corpuscular média; VCM, volume corpuscular médio.

EXAMES

- Hemograma;
- Contagem de reticulócitos;
- esfregaço de sangue periférico;
- Ferro, ferritina sérica;
- Dosagem de B12 sérica;

TRATAMENTO

ANEMIA FERROPRIVA

→ O tratamento da anemia ferropriva consiste na reposição oral ou venosa

REPOSIÇÃO ORAL: Com o estômago vazio, ou 30 minutos antes das principais refeições. O tratamento com ferro oral deve ser mantido durante um período suficiente para corrigir a anemia e repor os depósitos de ferro, o que geralmente significa pelo menos seis meses. A prevalência de efeitos colaterais é de até 30%, notadamente do TGI: pirose e dor epigástrica, náuseas, vômitos, empachamento, dor abdominal em cólica, diarreia e obstipação

Grupo Populacional	Recomendação	Duração
Crianças	3 a 6 mg de ferro elementar/Kg/dia	3 a 6 meses*
Adolescentes e adultos [#]	100 a 200 mg de ferro elementar/dia	3 a 6 meses*



OBS.: Falta de resposta ao ferro por via oral tem várias causas possíveis e todas deverão ser consideradas antes da indicação de ferro por via parenteral.

REPOSIÇÃO PARENTERAL: A resposta hematológica ao ferro por via parenteral não é mais rápida que a resposta à dosagem adequada de ferro por via oral, mas os depósitos são refeitos com mais rapidez.

- Via intramuscular está associada à dor local, pigmentação irreversível da pele e linfonodomegalia.
- A infusão venosa pode estar associada a irritação, dor e queimação do sítio de punção, náuseas, gosto metálico na boca, hipotensão e reação anafilatoide, sendo que o principal fator no aparecimento dessas reações é a velocidade de infusão.

ANEMIA MEGALOBLÁSTICA

Tabela 5.9 Tratamento da anemia megaloblástica

	Deficiência de vitamina B ₁₂	Deficiência de folato
Composto	Hidroxicobalamina	Ácido fólico
Via	Intramuscular*	Oral
Dose	1.000 µg	5 mg
Dose inicial	6 × 1.000 µg em 2-3 semanas	Diariamente por 4 meses
Manutenção	1.000 µg a cada 3 meses	Depende da doença de base; pode ser necessário tratamento durante toda a vida em anemias hemolíticas hereditárias crônicas, mielofibrose e diálise
Uso profilático	Gastrectomia total Ressecção ileal	Gravidez, anemias hemolíticas graves, diálise, prematuridade

*Alguns autores recomendam dose diária por via oral ou sublingual no tratamento de deficiência de vitamina B₁₂ (ver texto).

Aspectos éticos da hemotransusão

CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA: 2º - Se houver iminente perigo de vida, o médico praticará a transfusão de sangue, independentemente de consentimento do paciente ou de seus responsáveis.

Linfonodos

- Plaquetas: 150-450 mil
- Leucócitos: 5-10 mil

→ O exame físico dos linfonodos se faz por meio da inspeção e da palpação.

→ Deve-se avaliar em cada linfonodo: o tamanho, a consistência, a mobilidade, a coalescência, e a presença de sinais flogísticos como calor, rubor e dor.

→ Observar também se há alteração da pele da região.

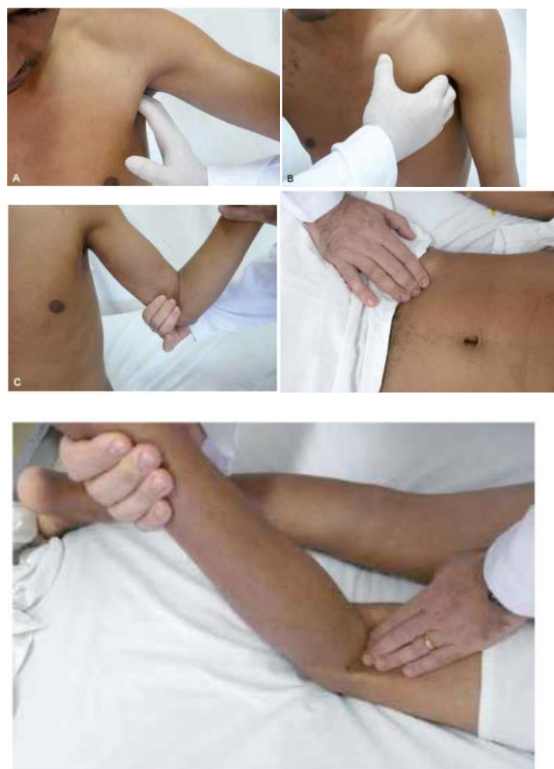
→ Os gânglios linfáticos são classificados em grupos:

- Pré-auriculares;
- Auriculares posteriores;
- Occipitais;
- Tonsilar;
- Sub-mandibulares;
- Submentonianos;
- Cervicais Anteriores Superficiais;
- Cervicais Anteriores Profundos;
- Cervicais posteriores;
- Supraclaviculares;
- Axilares;

- EpitrocLEAR;
- Inguinal;
- Poplíteo



Figura 12.6 Palpação dos linfonodos cervicais: nível I (A e B). Nível III (C), nível V (D), bucal, pré-auriculares e parotídeos. (E), retroauriculares e occipital (F).



OBS.: Linfonodo sentinela é o primeiro acometido.

CARACTERÍSTICAS NORMAIS DOS LINFONODOS: menor que 1cm² de diâmetro, fibroelástico, não aderido aos planos, indolor.

CARACTERÍSTICAS DE LINFONODOS ALTERADOS: qualquer localização, suspeitar se supraclavicular à esquerda, periumbilical, axilar, maior que



2,25 cm²; consistência pétrea, aderido aos planos profundos; indolor, geralmente

OBS.: Em exames de imagem, os benignos aparecem mais ovalados, enquanto os malignos são mais redondos e com bordas irregulares

EPÔNIMOS	
LOCALIZAÇÃO	EPÔNIMO
Supraclavicular à esquerda	Virchow/Troisier
Periumbilical	Irmã Maria José
Cadeia cervical posterior	Sinal de Winterbottom
Axilar	Rish
Inguinal profundo	Cloquet

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- Malignidades;
- Infecções;
- Doenças autoimunes;
- Miscelânea e causas incomuns;
- Iatrogênico.

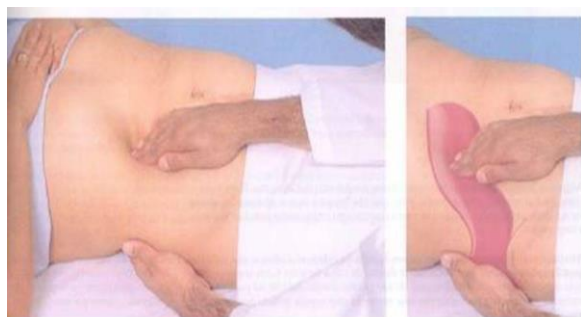
Hepatoesplenomegalia

→ Avaliação do fígado e do baço faz parte dos órgãos da resposta imune.

PAIPIÇÃO DO FÍGADO

- Limite inferior: a borda hepática costuma ser palpada a cerca de 1 a 2 cm do rebordo costal direito, na linha hemiclavicular, e a 5 a 8 cm do apêndice xifóide, na linha mediana (pode ser até 5 dedos em pessoas hipoastênicas magras, portadores de derrames pleurais à direita ou de enfisema pulmonar acentuado);
- Superfície hepática: macio e liso;
- Borda: fina;
- Sensibilidade: pouco doloroso

Técnica de Lemos Torres



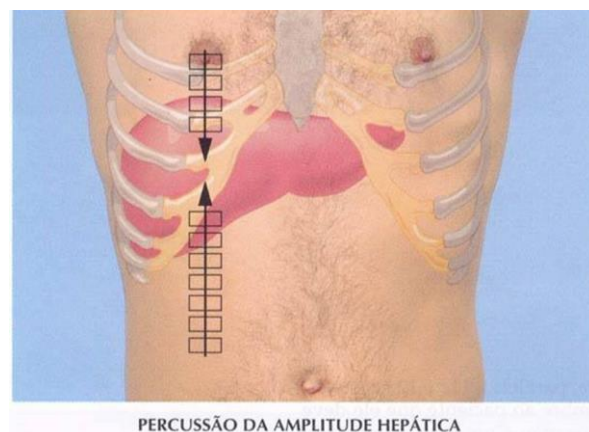
→ Mão esquerda sobre a região lombar, apoiando as duas últimas costelas, traciona-se o fígado para frente, com mão direita tenta-se palpar a borda hepática na inspiração profunda, com as falanges distais do indicador e médio

Método de Mathieu

→ O examinador posiciona-se à direita do tórax do paciente com as costas voltadas para seu rosto. Com as mãos paralelas sobre o hipocôndrio direito e as extremidades dos dedos fletidos, formando garras, tentando palpar o fígado na inspiração

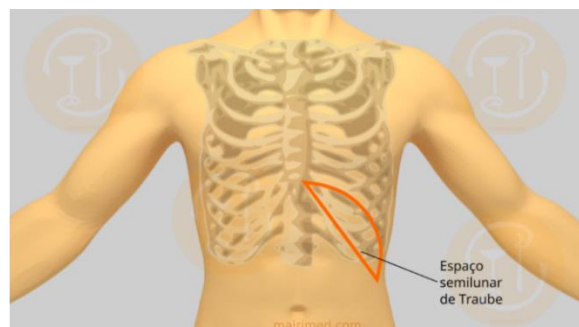


HEPATIMETRIA



ESPAÇO DE TRAUBE

→ O Espaço de Traube é uma zona de percussão de timbre timpânico de formato semilunar, limitada à direita pelo lobo esquerdo do fígado, acima pelo diafragma e pulmão esquerdos e à esquerda pela linha axilar anterior esquerda



→ De modo geral, esse espaço tem largura de 12cm e altura de 9cm, projetando-se sobre da 6ª à 9-10ª costelas. A expressão "Traube Livre", muito usado no cotidiano dos hospitais e acadêmicos, significa dizer que a percussão do espaço apresenta o timbre timpânico e que a loja de Traube encontra-se "livre" de ocupação, conforme normal

PAIPAÇÃO DO BAÇO

- O baço pode ser palpado quando atinge 2x ou 3x seu tamanho habitual;
- Em crianças menores saudáveis é possível palpar em 5% a 10% dos casos;
- O examinador a direita do paciente, traciona com a mão esquerda a face pósterio-lateral e inferior do gradil costal, deslocando-a em sentido anterior. Com a mão direita abaixo da margem costal esquerda, comprime em direção ao hipocôndrio esquerdo, tentando perceber o baço na inspiração profunda.

Posição de Shuster

→ Na posição de Shuster, posição intermediária entre decúbito lateral direito e o dorsal, faz-se o mesmo procedimento anterior.



Palpação do baço com o paciente na posição de Shuster



Arbovíroses

DENGUE: febre com duração de 2-7 dias, e duas ou mais das seguintes manifestações: náusea, vômitos; exantema; mialgias, artralgia; cefaleia, dor retro-orbital; petéquias; prova do laço positiva, leucopenia

CHIKUNGUNYA: febre maior que 38,5°C e artralgia ou artrite intensa

ZIKA: exantema maculopapular pruriginoso, acompanhado de 2 ou mais dos seguintes sintomas: febre, hiperemia conjuntival, poliartralgia, edema periarticular.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE ACORDO COM OS SINAIS E SINTOMAS - DENGUE

GRUPO A – ATENDIMENTO DE ACORDO COM O HORÁRIO DE CHEGADA	Ausência de sinais de alarme; sem comorbidades, não é grupo de risco e não possui condições clínicas especiais
GRUPO B – PRIORIDADE NÃO URGENTE	Ausência de sinais de alarme. Associado à: sangramento espontâneo de pele ou induzido; e/ou condições clínicas especiais (lactentes, gestantes, adultos > 65 anos); e/ou comorbidades; e/ou risco social
GRUPO C – URGÊNCIA, ATENDIMENTO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL	Presença de algum sinal de alarme e/ou pacientes com hematócrito acima de 10% do valor referência e/ou pacientes com plaquetas <50000
GRUPO D – EMERGÊNCIA, PACIENTE COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO.	Presença de sinais de choque, sangramento grave ou disfunção grave de órgãos

SINAIS DE ALARME: Acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural); hipotensão postural; hepatomegalia maior que 2 cm abaixo do rebordo costal; sangramento de mucosa; letargia e/ou irritabilidade; aumento do hematócrito, plaqueta menor que 50 mil, vômitos persistentes; dor abdominal intensa

SINAIS DE CHOQUE: taquicardia; extremidades frias; pulso fraco e filiforme; enchimento capilar < 2s; taquipneia; oligúria; pressão arterial convergente; hipotensão arterial; cianose

EXAMES

- NSI: até 5 dias;
- Soro IgM: após 3 dias;
- Soro IgG: só pra saber se teve contato

PROVA DO LAÇO



- A prova do laço é utilizada para avaliar a gravidade – prognóstico;
- Interromper a prova se graus elevados de petéquias;
- Paciente com sangramento não faz prova do laço;



- Paciente faz e dá negativo, solicita para vir 2 dias depois e repete o teste;
- Paciente faz e dá positivo não repete

OBS.: Obeso e presença de choque possuem quantidades subestimadas de petéquias

PERÍODO DE INCUBAÇÃO: 5-10 dias Incubação de até 2 semanas em áreas endêmicas

NOTIFICAÇÃO: investigação compulsória Até 1 semana pode notificar. Sinais de gravidade e óbito notificar até 24 horas

Lesões elementares da pele

→ A pele exerce importantes funções (revestimento, regulação da temperatura corporal, contato com o meio ambiente, isolamento do corpo, reserva alimentar) e reflete, de maneira acentuada, muitas das modificações sofridas pelo organismo

→ Pela sua acessibilidade aos dois métodos mais simples do exame físico – a inspeção e a palpação –, pode servir, do ponto de vista semiológico, como modelo para o aprendizado desses métodos.

→ As condições básicas para o exame da pele são:

- Iluminação adequada, preferencialmente a luz natural;
- Desnudamento ou exposição adequada das partes a serem examinadas;
- Conhecimento prévio dos procedimentos semiotécnicos.

→ Avaliar: textura, umidade, elasticidade, sensibilidade e coloração

LESÕES ELEMENTARES

→ Denominam-se lesões elementares as modificações do tegumento cutâneo determinadas por processos inflamatórios, degenerativos, circulatórios, neoplásicos, distúrbios do metabolismo ou por defeito de formação.

→ As lesões elementares classificam-se em:

- Alterações de cor;
- Elevações edematosas;
- Formações sólidas;
- Coleções líquidas;
- Alterações da espessura;
- Perda e reparações teciduais

ALTERAÇÕES DE COR – MANCHA OU MÁCULA

→ Manchas pigmentares: quando decorrem de alterações do pigmento melânico. Subdividem-se em três tipos:

- Hipocrômicas e/ou acrômicas: resultam da diminuição e/ou ausência de melanina. Podem ser observadas no vitiligo, pitíriase alba, hanseníase; algumas vezes são congênitas, como no nevo acrômico e no albinismo.

- Hiperocrômicas: dependem do aumento de pigmento melânico. Exemplos: pelagra, melasma ou cloasma, manchas hiperocrômicas dos processos de cicatrização, manchas hiperocrômicas da estase venosa crônica dos membros inferiores, nevos pigmentados, melanose senil.
- Pigmentação externa: substâncias aplicadas topicamente que produzem manchas do cinza ao preto. Exemplos: alcatrões, antralina, nitrato de prata, permanganato de potássio.



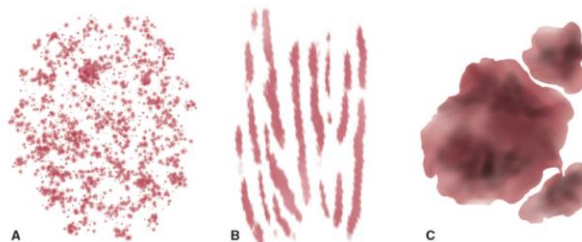
→ Manchas vasculares: decorrem de distúrbios da microcirculação da pele. As manchas vasculares subdividem-se em:

OBS.: São diferenciadas das manchas hemorrágicas por desaparecerem após compressão (digitopressão, quando se comprime a região com a polpa digital, vitropressão, quando a compressão é feita com uma lâmina de vidro transparente; e puntipressão, quando se emprega um objeto pontiagudo)

- Telangiectasias: são dilatações dos vasos terminais, ou seja, arteríolas, vênulas e capilares
- Mancha eritematosa ou hiperêmica: decorre de vasodilatação, tem cor rósea ou vermelho-viva e desaparece à digitopressão ou à vitropressão



→ Manchas hemorrágicas: são também chamadas "sufusões hemorrágicas" e, como já foi assinalado, não desaparecem pela compressão, o que as diferencia das manchas eritematosas. Não desaparecem por se tratar de sangue extravasado.



- Petéquias: quando são puntiformes, e com até 1 cm de diâmetro
- Vibices: quando tomam a forma linear. Esse termo também é empregado para lesão atrófica linear.



- Equimoses: quando são em placas, maiores que 1 cm de diâmetro.

ELEVAÇÕES EDEMATOSAS

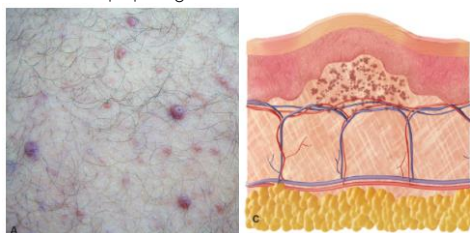
→ São elevações causadas por edema na derme ou hipoderme

Aqui se enquadra a lesão urticada ou tipo urticária, que corresponde a formações sólidas, uniformes, de forma variável (arredondadas, ovais, irregulares), frequentemente eritematosas e quase sempre pruriginosas, resultando de um edema dérmico circunscrito.

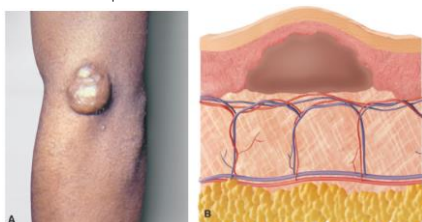


FORMAÇÕES SÓLIDAS

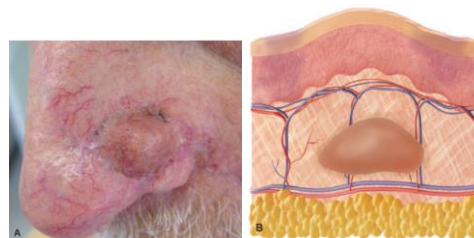
- Pápulas São elevações sólidas da pele, de pequeno tamanho (até 1,0 cm de diâmetro), superficiais, bem delimitadas, com bordas facilmente percebidas quando se desliza uma polpa digital sobre a lesão



- Tubérculos São elevações sólidas, circunscritas, de diâmetro maior que 1,0 cm, situadas na derme. A consistência pode ser mole ou firme.



- Nódulos, nodosidade e goma São formações sólidas localizadas na hipoderme, mais perceptíveis pela palpação do que pela inspeção. Quando de pequeno tamanho – grão de ervilha, por exemplo – são os nódulos. Se mais volumosas, são as nodosidades. Gomas são nodosidades que tendem ao amolecimento e ulceração com eliminação de substância semissólida.



- Vegetações São lesões sólidas, salientes, lobulares, filiformes ou em couve-flor, de consistência mole e agrupadas em maior ou menor quantidade.



COLEÇÕES LÍQUIDAS

- Vesícula É uma elevação circunscrita da pele que contém líquido em seu interior. Seu diâmetro não ultrapassa 1,0 cm. Diferença fundamental entre pápula e vesícula: a primeira é uma lesão sólida, e a segunda é constituída por uma coleção líquida.



- Bolha Também é uma elevação da pele contendo uma substância líquida em seu interior. A bolha tem diâmetro maior que 1,0 cm.
- Pústula É uma vesícula de conteúdo purulento.
- Abscessos São coleções purulentas, mais ou menos proeminentes e circunscritas, de proporções variáveis, flutuantes, de localização dermo-hipodérmica ou subcutânea. Quando acompanhados de sinais inflamatórios são chamados abscessos quentes. A ausência de sinais flogísticos caracteriza os abscessos frios.



- Hematomas São formações circunscritas, de tamanhos variados, decorrentes de derrame de sangue na pele ou tecidos subjacentes.



ALTERAÇÕES DA ESPESSURA

- Queratose É modificação circunscrita ou difusa da espessura da pele, que se torna mais consistente, dura e inelástica, em consequência de espessamento da camada córnea. O exemplo mais comum é o calo.
- Espessamento ou infiltração Traduz-se por aumento da consistência e da espessura da pele que se mantém depressível, menor evidência dos sulcos da pele, limites imprecisos.
- Liquenificação Consiste no espessamento da pele com acentuação das estrias, resultando em um quadriculado em rede como se a pele estivesse sendo vista através de uma lupa.



- Edema Consiste em acúmulo de líquido no espaço intersticial. A pele torna-se lisa e brilhante.
- Atrofias São adelgaçamentos da pele, a qual torna-se fina, lisa, translúcida e pregueada.

PERDA E REPARAÇÕES TECIDUAIS

→ São lesões oriundas da eliminação ou destruição patológicas e de reparações dos tecidos cutâneos.

- Escamas São lâminas epidérmicas secas que tendem a desprender-se da superfície cutânea.



- Erosão ou exulceração É o simples desaparecimento da parte mais superficial da pele, atingindo apenas a epiderme.



- Úlcera ou ulceração É a perda delimitada das estruturas que constituem a pele e que chega a atingir a derme. Tal fato a diferencia da escoriação.

- Fissuras ou rágades São perdas de substância linear, superficial ou profunda, e não determinada pela intervenção de qualquer instrumento cortante.



- Crosta É uma formação proveniente do ressecamento de secreção serosa, sanguínea, purulenta ou mista que recobre uma área cutânea previamente lesada.



- Escara É uma porção de tecido cutâneo necrosado, resultante de pressão isolada ou combinada com fricção e/ou cisalhamento.



- Cicatriz É a reposição de tecido destruído pela proliferação do tecido fibroso circunjacente. As exuberantes são representadas pela cicatriz hipertrófica e pelo quelóide.

OBS.: Fenômeno de Koebner – reproduz a lesão de doença de base em uma área onde a pele foi lesionada. Ex: desenvolvimento da lesão da psoríase na cicatriz da cesárea.

DERMOGRAFIA: quadro caracterizado por exagerada reação da pele quando a mesma é arranhada, mesmo que de forma leve.



Doenças exantemáticas

→ A doença exantemática é um conjunto de doenças infecciosas nas quais a erupção cutânea é a característica dominante, mas geralmente também apresentam manifestações sistêmicas.

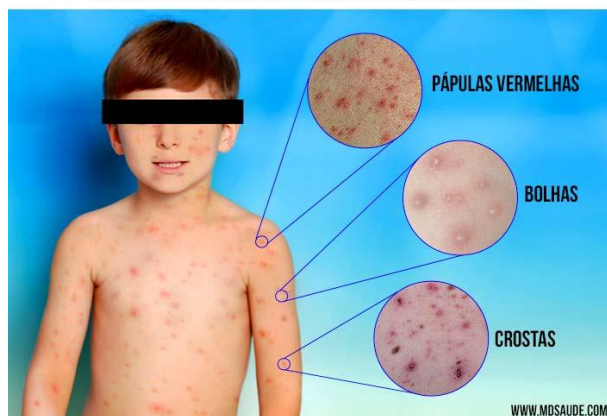
→ As principais doenças exantemáticas são: sarampo, rubéola, escarlatina, exantema súbito, eritema infeccioso, varicela, doença de Kawasaki e mão-pé-boca.

VARICELA - CATAPORA

→ Infecção viral primária, aguda, altamente contagiosa, caracterizada por surgimento de exantema de aspecto máculo-papular, torna-se vesicular, evolui rapidamente para pústulas e, posteriormente, forma crostas, em três a quatro dias. Podem ocorrer febre moderada e sintomas sistêmicos.

→ A principal característica clínica é o polimorfismo das lesões cutâneas, que se apresentam nas diversas formas evolutivas, acompanhadas de prurido. Em crianças, geralmente é benigna e autolimitada. Em adolescentes e adultos, em geral, o quadro clínico é mais exuberante.

ESTÁGIOS DAS LESÕES DE PELE DA CATAPORA (VARICELA)



TRANSMISSÃO: Pessoa a pessoa, por meio de contato direto ou de secreções respiratórias (disseminação aérea de partículas virais/aerossóis) e, raramente, através de contato com lesões de pele.

PERÍODO DE INCUBAÇÃO: Entre 14 e 16 dias, podendo variar de 10 a 21 dias após o contato. Pode ser mais curto em pacientes imunodeprimidos e mais longo após imunização passiva.

Manifestações clínicas

- Período prodromico: inicia-se com febre baixa, cefaleia, anorexia e vômito, podendo durar de horas até três dias. Na infância, esses pródromos não costumam ocorrer, sendo o exantema o primeiro sinal da doença.
- Período exantemático: as lesões comumente aparecem em surtos sucessivos de máculas que evoluem para pápulas, vesículas, pústulas e crostas. Tendem a surgir mais nas partes cobertas do corpo, podendo aparecer no couro

cabeludo, na parte superior das axilas e nas membranas mucosas da boca e das vias aéreas superiores. O aparecimento das lesões em surtos e a rápida evolução conferem ao exantema o polimorfismo regional característico da varicela: lesões em diversos estágios (máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas), em uma mesma região do corpo.

Tratamento e prevenção

- Cuidados locais e higiene – cortar as unhas;
- Aciclovir (VO/EV) > 12 anos, risco de complicação, imunocomprometidos, caso secundário domiciliar.
- Vacinação de rotina: 15 meses (tetra viral) e 4 anos (varicela – reforço).
- Bloqueio: para contactantes que não tem a vacinação completa. Vacina até 120h e Imunoglobulina Varicela Zoster (IGHAVZ) até 96h.
- Isolamento de contato e respiratório, até formação de crostas em todas as lesões.

SARAMPO

CASO SUSPEITO DE SARAMPO: Todo indivíduo que, independente da idade e situação vacinal, apresentar febre e exantema maculopapular, acompanhados de um ou mais dos seguintes sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite.

→ Doença viral aguda caracterizada por febre, tosse, coriza, e conjuntivite seguidas, após três a cinco dias, por um exantema eritematoso maculopapular de progressão crânio-caudal, começando atrás das orelhas e na linha do cabelo e, em seguida, se espalhando para o resto do corpo, braços e pernas, de distribuição centrípeta, que não poupa região palmo-plantar.

Figuras 4 e 5. Exantema do sarampo:



→ Durante o período prodromico, um a dois dias antes do aparecimento do exantema, pode-se ter a presença das manchas de Koplik (exantema fugaz, caracterizado por pequenas manchas azul-esbranquiçadas no revestimento interno das bochechas, mais comumente na região oposta aos dentes molares), sinal patognomônico do sarampo.



Figura 6. Sinal de Koplik



MOBILIFORME: áreas de pele são e áreas de pele descamativa

MÃO-PÉ-BOCA

→ Enfermidade contagiosa causada pelo vírus Coxsackie da família dos enterovírus que habitam normalmente o sistema digestivo e também podem provocar estomatites (espécie de afta que afeta a mucosa da boca). Embora possa acometer também os adultos, ela é mais comum na infância, antes dos cinco anos de idade.



- febre alta nos dias que antecedem o surgimento das lesões;
- aparecimento, na boca, amídalas e faringe, de manchas vermelhas com vesículas branco-acinzentadas no centro que podem evoluir para ulcerações muito dolorosas;
- erupção de pequenas bolhas em geral nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, mas que pode ocorrer também nas nádegas e na região genital;
- mal-estar, falta de apetite, vômitos e diarreia;
- por causa da dor, surgem dificuldade para engolir e muita salivação.

IMPORTANTE: A transmissão se dá pela via fecal/oral, através do contato direto entre as pessoas ou com as fezes, saliva e outras secreções, ou então através de alimentos e de objetos contaminados. Mesmo depois de recuperada, a pessoa pode transmitir o vírus pelas fezes durante aproximadamente quatro semanas. O período de incubação oscila entre um e sete dias. Na maioria dos casos, os sintomas são leves e podem ser confundidos com os do resfriado comum.

ERITEMA INFECCIOSO

- Face esbofetada – Parvovírus;
- Aplasia de medula – pacientes com anemia hemolítica



RUBÉOLA

- Febre baixa;
- Exantema máculo-papular;
- Linfadenopatia retroauricular, occipital e cervical



ESCARLATINA

→ A escarlatina é uma doença infecciosa aguda, causada por uma bactéria chamada estreptococo beta hemolítico do grupo A.

→ É constituída por pequenas manchas do tamanho de uma cabeça de alfinete, cor vermelho vivo e que são mais intensas na face, nas axilas e nas virilhas, poupando a região em volta da boca que se apresenta pálida, e as palmas das mãos e plantas dos pés.



→ Estas alterações atingem também a língua, que se apresenta branca e saburrosa no início, ficando depois com aspecto de framboesa (língua em framboesa), devido ao aumento das papilas que adquirem um tom vermelho arroxeado nos bordos e na ponta da língua.



→ A erupção da escarlatina, que confere à pele um toque áspero, desaparece ao fim de seis dias, acompanhando-se de uma descamação fina durante alguns dias. Nas mãos e nos pés a descamação pode ser em lâminas.

Hanseníase

FORMAS CLÍNICAS

→ A hanseníase se apresenta em 4 formas clínicas de acordo com a classificação de Madri: (SMS, 2018).

HANSENÍASE INDETERMINADA

→ Em geral é a forma inicial da doença e os pacientes se apresentam com uma ou poucas lesões, sem local preferencial. As lesões apresentam-se como: (SMS, 2018).

- Manchas esbranquiçadas (hipocrômicas) com bordas bem ou mal delimitadas.
- Diminuição ou ausência de sudorese quando comparada a área circunjacente (hipo ou anidrose).
- Alteração da sensibilidade térmica mais precoce e de sensibilidade dolorosa em geral mais tardia (hipo ou anestesia).
- Rarefação de pelos.
- Não há espessamento de tronco nervoso.



Mácula hipocrômica mal delimitada



Mácula hipocrômica bem delimitada

OBS.: Pode ocorrer área de hipoestesia sem lesão visível

HANSENÍASE TUBERCULÓIDE

→ Os pacientes apresentam-se com uma ou poucas lesões: (SMS, 2018).

- Máculas, pápulas ou placas eritematosas bem delimitadas, infiltradas e de tamanhos variados. Mácula hipocrômica mal delimitada. Mácula hipocrômica bem delimitada.

Centro da lesão pode ser mais claro e a borda mais eritematosa, podendo ser confundido com micose. Devemos suspeitar de hanseníase nos casos tratados como micose que não responderam ao tratamento antifúngico prescrito e naquelas com ausência de prurido.

- A distribuição das lesões é assimétrica.
- Os pêlos também estão ausentes. As alterações de sensibilidade são precoces (hipo ou anestesia).

- O comprometimento de um tronco neural pode estar presente, em geral é próximo à lesão cutânea.



Placas eritematosas



HANSENÍASE DIMORFA OU BORDERLINE

→ As lesões podem tanto assemelhar-se ao pólo tuberculóide quanto ao pólo virchowiano e se apresentam como: (SMS, 2018).

- Numerosas lesões cutâneas, que tendem à distribuição simétrica, de diversos tipos e dimensões (máculas, pápulas e placas) revelando o aspecto polimórfico das lesões.
- Margens bem ou mal definidas.
- Lesões infiltradas anulares ou foveolares com borda interna nítida e externa apagada (lesão em queijo suíço).

IMPORTANTE: Maior propensão às neurites (inflamação dos troncos neurais) e incapacidades físicas (SMS, 2018).



Placas eritemato infiltradas foveolares



Placa eritemato infiltrada bem delimitada com aspecto foveolar.



Placas eritemato violáceas foveolares na face



Placa infiltrada eritemato-violácea

HANSENÍASE VIRCHOWIANA

→ Caracteriza-se por: (SMS, 2018).

- Infiltração difusa: corpo e/ou face (facies leonina).
- Nódulos (hansenomas).
- Infiltração de pavilhões auriculares.
- Madarose.



- Entupimento nasal (rinite seca), epistaxe, crostas hemáticas na mucosa nasal
- Sensação de areia nos olhos, eritema conjuntival
- Anestesia de mãos e pés em luva e bota
- Desabamento nasal
- Anosmia



Múltiplas pápulas e nódulos eritematosos difusos por toda a pele



Infiltração da face, pavilhões auriculares e malarose



Infiltração dos pavilhões auriculares

EXAME DERMATONEUROLÓGICO

SENSIBILIDADE TÉRMICA

→ A sensibilidade térmica deve ser testada com recipientes (preferencialmente tubos de vidro) contendo água fria e quente. Os tubos com as diferentes temperaturas devem ser colocados em contato com a pele de forma aleatória, iniciando pelo quente. Atentar para a temperatura da água a fim de evitar queimaduras (SMS, 2018).

DICA: Sugere-se utilizar os tubos de coleta de exame de sangue, um contendo água fria e outro água aquecida (SMS, 2018)

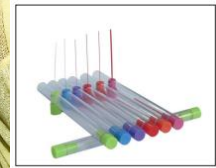


Tubo de vidro para coleta de sangue usado para testar a sensibilidade térmica com água aquecida e água fria

SENSIBILIDADE DOLOROSA

→ A sensibilidade protetora reflete a capacidade de diferenciar estímulos desconfortáveis e/ou dolorosos, sendo rotineiramente referida como sensibilidade dolorosa (SMS, 2018)

→ Tal sensibilidade deve ser testada com estesiômetro lilás - as demais cores do conjunto de estesiômetros se destinam a outro fim. O estesiômetro deve ser posicionado em ângulo de 90° em relação a área testada e feita pressão suficiente para gerar uma curvatura e permitir que o paciente sinta o toque do filamento (SMS, 2018).



Kit de estesiômetros

→ A sensibilidade dolorosa pode ser pesquisada com agulha de injeção descartável, devendo o paciente identificar se é a ponta ou o fundo da agulha que está tocando a sua pele (SMS, 2018)

SENSIBILIDADE TÁTIL

→ A sensibilidade tátil deve ser testada com algodão seco. O paciente deve perceber o toque do algodão na área testada (SMS, 2018)



O toque mais leve que se pode sentir é do filamento:	INTERPRETAÇÃO	Código tradicional para mapeamento no prontuário:
Verde (Nominal: 0,07gf)	- Sensibilidade dentro da faixa considerada normal para mão e pé.	Bolinha verde ●
Azul (Nominal: 0,2gf)	- Sensibilidade diminuída na mão, com dificuldade quanto a discriminação fina. Ainda dentro do "normal" para o pé.	Bolinha azul ●
Violeta (Nominal: 2,0gf)	- Sensibilidade protetora para a mão diminuída, permanecendo o suficiente para prevenir lesões. - Dificuldade com a discriminação de forma e temperatura.	Bolinha roxa ●
Vermelho escuro (Nominal: 4,0gf)	- Perda da sensação protetora para a mão, e às vezes, para o pé. - Vulnerável a lesões. - Perda da discriminação quente / frio.	Bolinha vermelha ●
Laranja (Nominal: 10gf)	- Perda da sensação protetora para o pé, ainda podendo sentir pressão profunda e dor.	"X" em vermelho ✗
Magenta / rosa (Nominal: 300gf)	- Sensibilidade à pressão profunda mantida, podendo ainda sentir dor.	Círculo vermelho ○
Nenhuma resposta	- Perda de sensibilidade à pressão profunda, normalmente não podendo sentir dor.	Bolinha preta ●

AValiação DA FUNÇÃO NEURAL

→ Os principais troncos nervosos periféricos acometidos na hanseníase são:

- Face – Trigêmeo e Facial: podem causar alterações na face, nos olhos e no nariz;
- Braços – Radial, Ulnar e Mediano: podem causar alterações nos braços e nas mãos;
- Pernas – Fibular e Tibial: podem causar alterações nas pernas e nos pés

